

RECEITA MÉDICA

MÉDICO PRESCRITOR

Nome: fernando

CRM: sfgh

Especialidade: radiologista

Data: 22/02/2026 12:54

PACIENTE

Nome: xavier Tchivela

Idade: 24 anos

Gênero: masculino

DIAGNÓSTICO

TIPO DE EXAME:

Ressonância Magnética

DESCRIÇÃO:

nm

OBSERVAÇÕES:

m

RESULTADO:

****Relatório de Análise de Imagem Médica****

****Paciente:**** Xavier Tchivela

****Idade:**** 24 anos

****Gênero:**** Masculino

****1. Descrição da imagem e qualidade técnica****

A imagem fornecida é uma microfotografia de um esfregaço de sangue periférico corado (provavelmente com coloração tipo Romanowsky, como Giemsa ou Wright). A qualidade técnica da imagem é boa, com clareza adequada para a identificação dos elementos celulares e estruturas parasitárias. O campo de visão mostra uma população predominantemente de eritrócitos.

* ****Nota sobre o tipo de exame:**** É importante ressaltar que, embora o contexto clínico mencione "Ressonância Magnética" como tipo de exame, a imagem apresentada é inequivocamente um esfregaço de sangue periférico sob microscopia óptica, o que é fundamental para a análise hematológica e parasitológica.

****2. Achados principais****

* ****Eritrócitos (Glóbulos Vermelhos):**** Observa-se a presença de anisocitose (variação no tamanho dos eritrócitos) e poiquilocitose (variação na forma dos eritrócitos), com algumas células exibindo hipocromia (centro pálido aumentado).

* ****Parasitas Intraeritrocitários:**** O achado mais significativo é a presença de múltiplos parasitas dentro dos eritrócitos. Estes parasitas se apresentam principalmente como formas anelares (trofozoítos jovens), caracterizadas por pequenos anéis de citoplasma e um ponto de cromatina, e alguns trofozoítos mais maduros. Alguns parasitas parecem conter pigmento malárico (hemozoína). Em alguns eritrócitos, observa-se mais de um parasita.

****3. Diagnóstico sugerido****

Os achados são altamente sugestivos de ****Malária****. A presença de parasitas intraeritrocitários é o critério diagnóstico para infecção malárica. A morfologia predominante de formas anelares e trofozoítos jovens, por vezes múltiplos por eritrócito, é compatível com diversas espécies de *Plasmodium*, incluindo *Plasmodium falc...*
[Diagnóstico completo disponível no sistema]

PRESCRIÇÃO MÉDICA

****PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS:****

****1. Artemether + Lumefantrina (Ex: Coartem®)****

* **Princípio Ativo:** Artemether (20mg) + Lumefantrina (120mg)
* **Dosagem:** 4 comprimidos (totalizando Artemether 80mg + Lumefantrina 480mg)
* **Frequência:**
* **1ª dose:** Imediatamente (0 hora)
* **2ª dose:** 8 horas após a 1ª dose
* **3ª dose:** 12 horas após a 2ª dose (24 horas após a 1ª dose)
* **4ª dose:** 12 horas após a 3ª dose (36 horas após a 1ª dose)
* **5ª dose:** 12 horas após a 4ª dose (48 horas após a 1ª dose)
* **6ª dose:** 12 horas após a 5ª dose (60 horas após a 1ª dose)
* **Duração do Tratamento:** 3 dias (total de 6 doses)
* **Via de Administração:** Oral
* **Quantidade Total:** 24 comprimidos (4 comprimidos/dose x 6 doses)
* **Observação:** Os comprimidos devem ser tomados com alimentos ou bebidas ricas em gordura (leite, iogurte) para otimizar a absorção.
* **2. Paracetamol (Ex: Tylenol®)**
* **Princípio Ativo:** Paracetamol
* **Dosagem:** 750 mg
* **Frequência:** A cada 6 horas (conforme a necessidade para febre ou dor)
* **Duração do Tratamento:** Enquanto houver sintomas (Não exceder 4g/dia)
* **Via de Administração:** Oral
* **Quantidade Total:** 20 comprimidos

7. **RETORNO:** Acompanhamento clínico e laboratorial diário é crucial nos primeiros dias. O retorno ao médico clínico/infectologista deverá ser agendado conforme a evolução, mas usualmente após 3 dias do início do tratamento e posteriormente para avaliação da cura parasitológica.

* **CONTRAINDICAÇÕES:** O Artemether/Lumefantrina é geralmente bem tolerado. Usar com cautela em pacientes com arritmias cardíacas preexistentes, histórico familiar de morte súbita, ou uso concomitante de medicamentos que prolongam o intervalo QT.

* **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** Informar ao médico sobre todos os medicamentos em uso, incluindo fitoterápicos e suplementos. Interage com alguns antifúngicos azólicos, antirretrovirais (inibidores de protease), alguns antiarrítmicos, antidepressivos e indutores/inibidores potentes do CYP3A4.

* **EFEITOS COLATERAIS COMUNS:** Náuseas, vômitos, dor abdominal, dor de cabeça, tontura, astenia, mialgia. Em caso de efeitos colaterais graves ou persistentes, procurar atendimento médico.

* **ARMAZENAMENTO:** Manter os medicamentos em suas embalagens originais, em temperatura ambiente (15°C a 30°C), protegidos da luz e umidade, e fora do alcance de crianças.

* **DIRIGIR E OPERAR MÁQUINAS:** A malária e o tratamento podem causar tontura ou fadiga. O paciente deve ser aconselhado a evitar dirigir ou operar máquinas se sentir esses sintomas.

[ASSINATURA DO MÉDICO]

Dr. Fernando

Radiologista - CRM: sfgh

[Endereço do Consultório]

[Telefone de Contato]

[E-mail, se aplicável]

RECOMENDAÇÕES

****RECOMENDAÇÕES MÉDICAS ESPECÍFICAS:****

1. ****REFERÊNCIA URGENTE:**** Este paciente deve ser encaminhado ****imediatamente**** para um médico clínico geral ou infectologista para avaliação clínica completa, manejo e acompanhamento da infecção malárica.
 2. ****CONFIRMAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIE:**** Realizar análise complementar de esfregaço de sangue (gota espessa e estendida) por microscopista experiente para contagem da parasitemia e identificação definitiva da espécie de *Plasmodium*. Se disponível, considerar métodos moleculares (PCR).
 3. ****MONITORIZAÇÃO CLÍNICA E LABORATORIAL:****
 - * ****Avaliação Clínica:**** Monitorização de sinais vitais, nível de consciência, sinais de gravidade (dispneia, icterícia, convulsões, sangramentos, oligúria).
 - * ****Exames Laboratoriais:**** Hemograma completo (diariamente nos primeiros dias), função renal (creatinina, ureia), função hepática (bilirrubinas, TGO, TGP), glicemia e eletrólitos.
 4. ****HIDRATAÇÃO E REPOUSO:**** Manter hidratação adequada (via oral ou intravenosa, se necessário). Repouso absoluto durante a fase aguda da doença.
 5. ****CONTROLE SINTOMÁTICO:**** Além do Paracetamol, outras medidas para controle da febre (compressas frias) e alívio de sintomas devem ser implementadas conforme a necessidade.
 6. ****SINAIS DE ALERTA PARA RETORNAR AO MÉDICO/PRONTO-SOCORRO:**** Piora da febre, confusão mental, convulsões, dificuldade respiratória, dor abdominal intensa, vômitos persistentes, urina escura, coloração amarelada da pele ou olhos (icterícia), sangramentos incomuns.
- **OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:****

IMPORTANTE:

Esta receita foi baseada no diagnóstico do paciente. Em caso de dúvidas, consultar o médico prescritor.

fernando
CRM: sfgh
radiologista

Receita gerada em 22/02/2026 12:54

ID da receita: 2

Sistema Médico - Receita eletrônica